

	Guía Hospitalaria: Síncope	VER: 00 Vigencia: jun 2022 Res: 587
--	-----------------------------------	---



GUÍA HOSPITALARIA SÍNCOPE

Elaboración:

Servicio de Emergencias Hospital Pediátrico H. Notti

Revisión:

Servicio de Cardiología

Servicio de Neurología

Indice

Introducción: Objetivos.....	3
Definiciones.....	3
Etiología.....	3
Diagnóstico.....	5
Exámenes complementarios.....	6
Interconsulta.....	6
Diagnóstico diferencial.....	6
Tratamiento.....	7
Criterios de internación.....	8
Anexo.....	9
Bibliografía.....	10

Introducción

Objetivos: Actualizar y mejorar la atención basado en la evidencia de los niños y adolescentes que presentan Síncope atendidos en nuestro hospital, así como también de la detección oportuna de la etiología y los diagnósticos diferenciales para realizar un tratamiento adecuado.

El síncope se debe a una pérdida transitoria del flujo sanguíneo cerebral, de etiología variada. Hasta el 15% de los niños tiene un síncope antes de llegar a la adolescencia. Aunque puede deberse a un problema grave, en su gran mayoría son de naturaleza benigna. Además, suele generar una gran preocupación, lo que hace que sea un motivo de consulta frecuente en Urgencias en la edad pediátrica. En general, una buena historia clínica y una exploración física minuciosa serán suficientes para detectar posibles signos de alarma que nos hagan pensar en un posible origen cardíaco.

Definiciones

Se define el **Síncope** como la pérdida brusca y transitoria de la conciencia y del tono postural, de breve duración y con recuperación completa e inmediata, que se origina como consecuencia de una disminución en la perfusión arterial cerebral regulado por mecanismos del sistema autónomo con una activación excesiva predominante simpática al inicio generando una descarga de catecolaminas y atenuándose después, dando lugar al predominio del tono parasimpático.

Se define **Presíncope** como sensación prodrómica de clínica vegetativa, con mareo, giro de objetos, sudoración fría, visión borrosa y/o palidez, sin llegar a la pérdida de conciencia.

Etiología

La etiología es muy variada. Es más común en mujeres. La causa más frecuente en la infancia es el síncope vasovagal o neurocardiogénico (61-80%). En un pequeño porcentaje puede ser síntoma de una enfermedad cardíaca potencialmente letal.

La evaluación del niño con un síncope supone un desafío para el médico de Urgencias, el electrocardiograma (ECG) es una de las pruebas complementarias recomendadas para evaluar al paciente. Sin embargo, se estima que, en la edad pediátrica, el origen cardiogénico es la causa del 8% de los síncope. De hecho, la mayoría de síncope son autonómicos, especialmente en preadolescentes y adolescentes, debido al desequilibrio de reflejos vasomotores desencadenado en diversas situaciones como hipotensión, estrés, miedo, dolor, fiebre o espasmo del sollozo. Clásicamente, se han descrito una serie de **signos de alarma** en relación con un mayor riesgo de presentar una seria condición de base:

- presentación durante el ejercicio
- inicio brusco

- en posición supina
- desencadenado por ruido o susto
- sin cortejo vegetativo previo
- asociado a dolor torácico
- historia de palpitations previa al síncope
- pérdida de consciencia prolongada
- necesidad de RCP (reanimación cardiopulmonar)
- antecedentes personales o familiares de muerte súbita o cardiopatía estructural o arritmias
- presencia de soplos cardíacos patológicos
- sospecha de otras causas.

Etiología del Síncope		
Síncope Neurocardiogénico	Síncope vasovagal	Ortostatismo prolongado, lugares cerrados, dolor, instrumentación médica
	Síncope situacional	Micción, defecación, deglución, tras peinado
Origen Cardíaco	Arritmias	Síndrome QT largo Taquicardia ventricular Displasia arritmogénica del ventrículo derecho Taquicardia supraventricular Disfunción del nodo sinusal
	Disfunción cardíaca	Miocarditis Miocardiopatía dilatada Coronaria de origen anómala Enfermedad de Kawasaki
	Obstrucción a la salida ventricular	Estenosis aórtica Miocardiopatía hipertrófica obstructiva Hipertensión pulmonar
Origen Neurológico		Epilepsia disautonómica autolimitada de la infancia Migraña Accidente isquémico transitorio (baja frecuencia pediátrica)
Origen Psicógeno		Hiperventilación Reacción de conversión
Origen Metabólico		Hipoxemia Hipoglucemia Intoxicación

Síncope vasovagal o neurocardiogénico: Se desencadena por la disminución brusca de la precarga al ponerse de pie en relación a una disregulación autonómica. Suelen presentar una fase prodrómica que termina con sensación de inestabilidad, pérdida del tono postural y de la conciencia. Suele tener una duración de 15-30 segundos, con recuperación posterior completa. Otras entidades similares que podrían englobarse en este tipo de síncope son el situacional, que se produce en situaciones concretas como la deglución, defecación o el peinado, y el espasmo del sollozo.

	Guía Hospitalaria: Síncope	VER: 00 Vigencia: jun 2022 Res: 587
--	-----------------------------------	---

Síncopes de origen cardiogénico: Generalmente se presentan sin pródromos, a veces precedidos de dolor torácico o palpitaciones. Debemos sospecharlos si se producen durante el ejercicio. El origen del problema puede estar relacionado con una disfunción miocárdica (miocarditis, miocardiopatía dilatada), obstrucción de salida ventricular (estenosis aórtica, pulmonar, miocardiopatía hipertrófica obstructiva, hipertensión pulmonar) o arritmias (síndrome QT largo, disfunción del nodo sinusal, taquicardia supraventricular, taquicardia ventricular).

En la clasificación de síncope se hace referencia a los desencadenados por ingesta de tóxicos, alteraciones metabólicas o de origen psicógeno, que no son realmente síncope.

Diagnóstico

Para el diagnóstico es básico realizar una buena historia clínica que describa el episodio de forma minuciosa, con una anamnesis detallada, recogiendo antecedentes personales y familiares que puedan resultar de interés. Esto, junto a la exploración física, permitiría definir la etiología en más del 77% de los casos.

En la anamnesis debemos recoger:

- existencia o no de pródromos (mareo, sudoración, visión borrosa, palidez, náuseas, palpitaciones)
- factores precipitantes (calor, estrés, dolor, visión de sangre, ruido, tos)
- posición en la que se encontraba el paciente inmediatamente previo al síncope (supino a bipedestación, sedestación, bipedestación)
- si estaba realizando actividad física
- cambios de coloración
- convulsiones (retrodesviación de la mirada, hipertonía, movimientos tónicos o tónico-clónicos, las posturas distónicas que suelen no estar presentes en los eventos de origen convulsivo)
- duración del episodio
- recuperación posterior (habitualmente un evento que presenta un periodo de recuperación prolongado debe hacer pensar en crisis convulsiva)

La exploración física debe ser completa, prestando especial atención a signos cardiovasculares y neurológicos. Debe realizarse toma de signos vitales, sobre todo frecuencia cardíaca y tensión arterial en supino y bipedestación.

Exámenes complementarios

La mayoría de los autores coinciden en la recomendación de realizar un **electrocardiograma de doce derivaciones** en todo cuadro sincopal. Aún así, solo se encuentran hallazgos patológicos en

	Guía Hospitalaria: Síncope	VER: 00 Vigencia: jun 2022 Res: 587
--	-----------------------------------	---

un 5% de los casos. Si hay una sospecha franca de causa cardiológica, será necesaria la evaluación por el especialista en cardiología infantil.

Interconsultas:

Cardiología

1. Síncopes que se desencadenan con ejercicio (cardiopatía estructural con obstrucción a la salida de VI, arritmias). El síncope que ocurre tras finalizar el ejercicio muchas veces es neurocardiogénico o vasovagal.
2. Síncopes provocados por situaciones de estrés o peligro (arritmias en el síndrome de QT largo, taquicardia ventricular catecolaminérgica). También síncopes asociados a natación o durante el sueño o con estímulos auditivos (p. ej.: despertador)
3. Antecedentes familiares de muerte súbita en personas jóvenes
4. Antecedentes familiares de cardiopatía o arritmias de base genética: miocardiopatía hipertrófica, displasia arritmogénica del ventrículo derecho, síndrome de QT largo, síndrome de Brugada.
5. Hallazgos en la anamnesis o exploración que sugieran la presencia de cardiopatía
6. ECG patológico (QT largo, preexcitación, hipertrofia del ventrículo izquierdo)
7. Síncopes bruscos, asociados a traumatismos y sin pródromo
8. Aquellos casos en que la anamnesis no sea clara o sugerente de síncope vasovagal

No es necesario realizar pruebas de laboratorio, salvo historia o exploración física sugestiva de alteraciones electrolíticas, trastornos alimenticios u otras causas.

Neurología

En caso de hallazgos en la exploración neurológica (focalidad, período de recuperación prologado), será necesario realizar un electroencefalograma y la evaluación por el especialista en neurología infantil.

Diagnóstico diferencial

Se hará con otras pérdidas de conciencia que no son reales, completas o súbitas, y con alteraciones neurológicas, a lo que ayudarán los síntomas que acompañan a la pérdida de conciencia.

El síncope debe diferenciarse, en primer lugar, de otros cuadros en los que hay una pérdida de conciencia aparente o real, pero que no cumple las características que lo definen, es decir, no es súbita, completa o con recuperación espontánea.

1. **Alteraciones metabólicas:** La hipoxia, hipercarbia, hipocapnia secundaria a hiperventilación, hipoglucemia, pueden dar lugar a una pérdida de conciencia. Se

diferencia de la producida por un síncope en que no es de instauración rápida, y puede tardar más en recuperarse, además, muchas veces no es completa.

2. **Intoxicaciones:** Al igual que las alteraciones metabólicas, las intoxicaciones por alcohol, benzodiazepinas, barbitúricos, no producen una pérdida de conciencia de instauración y recuperación rápida.
3. **Síncope psicógenos:** Los ataques de ansiedad suelen dar cuadros presincopecales sin llegar a tener pérdida de conciencia. Se producen por la acción vasodepresora de la hiperventilación. En las reacciones de conversión, no existe una pérdida de conciencia real, sino aparente, que se produce en presencia de testigos y no se acompaña de cambios en la coloración cutánea, frecuencia cardíaca o tensión arterial, generalmente se trata de un diagnóstico de exclusión.
4. **Crisis epilépticas:** Son episodios paroxísticos, producidos por una descarga neuronal excesiva, con manifestaciones motoras, sensoriales o psíquicas. Pueden cursar con o sin pérdida de conciencia. El diagnóstico diferencial se plantea entre la Epilepsia con crisis disautonómicas autolimitadas de la infancia y los síncope convulsivos. Recordar fundamentalmente que, en que las crisis epilépticas generalmente no hay desencadenantes, como ocurre muchas veces en los síncope (bipedestación prolongada, instrumentación médica). En el síncope hay palidez intensa, si el síncope es convulsivo, la hipertonia o movimientos clónicos ocurren al cabo de unos segundos, mientras que, en la crisis epiléptica, aparecen desde el principio. En ambos casos puede haber relajación de esfínteres, trismus mandibular o hipersalivación. En el síncope la recuperación de conciencia es inmediata a la caída por la mejoría de la perfusión cerebral, mientras que en la crisis epiléptica la recuperación es más lenta y hay somnolencia postcrítica.
5. **Accidente cerebrovascular:** La presencia de cefalea intensa o signos de focalidad neurológica postcrítica caracterizan esta patología.

Tratamiento

El tratamiento dependerá de la causa subyacente. En el caso del síncope vasovagal, solo será necesario tranquilizar a los pacientes y pautar algunas normas de conducta para evitar recidivas. (Anexo1)

Actitud o medidas urgentes

El paciente que sufra un episodio sincopal recuperará la conciencia espontáneamente sin intervención. La única actitud que se debe tomar para ayudarle es colocarle en la posición de decúbito lateral, para evitar que pueda aspirar sus propias secreciones. También se aconseja situarle en posición de Trendelenburg o elevarle los miembros inferiores para aumentar el retorno venoso y por tanto el volumen de llenado ventricular, el gasto cardíaco y la perfusión cerebral.

	Guía Hospitalaria: Síncope	VER: 00 Vigencia: jun 2022 Res: 587
--	-----------------------------------	---

Medidas terapéuticas diferidas

Los pacientes que solicitan atención médica después de haber sufrido un síncope vasovagal requerirán únicamente que se les tranquilice, informándoles sobre la naturaleza benigna de esta patología y pautando normas de conducta para evitar recidivas (evitar situaciones desencadenantes, ingesta adecuada de líquidos, no realizar periodos prolongados de ayuno).

Se debe informar de la probabilidad de nuevas recurrencias, y ayudar a reconocer al paciente sus síntomas prodrómicos, lo que le permitirá reconocer la inminencia de un nuevo episodio y así tratar de evitarlo.

Criterios de internación

- Episodio que presente signos de alarma.
- Duda diagnóstica que precise completar estudios
- Angustia familiar

Anexo 1

Instructivo para familiares

¿QUÉ ES UN SÍNCOPE?

El síncope es una pérdida de conciencia brusca y breve: el niño se pone pálido, deja de responder y pierde la fuerza pudiendo caerse al suelo. Después, se recupera rápidamente, en un par de minutos. A veces, cuando el niño pierde el conocimiento se producen 2 ó 3 sacudidas de las extremidades. Generalmente, antes del desmayo el niño se siente mal con náuseas, dolor abdominal, visión borrosa, sudoración o zumbido en los oídos. Estos síntomas pueden ayudar en el futuro para que su hijo se dé cuenta de lo que va a ocurrir y pueda evitar nuevos desmayos. Puede desencadenarse por dolor, miedo, ansiedad, cuando se está de pie, parado en el mismo lugar durante mucho tiempo o al levantarse bruscamente cuando se está acostado.

¿QUÉ DEBE HACER?

- Si conoce las situaciones que le causan los desmayos debe evitarlas o cambiarlas. Por ejemplo, no hay que incorporarse bruscamente cuando se está sentado o acostado. Si el niño se suele marear cuando le sacan sangre adviértalo antes a la enfermera para que le recueste durante la extracción.
- Cuando el niño comience a sentirse mal debe sentarse o recostarse de inmediato para evitar el síncope y la caída. Es conveniente que respire lenta y profundamente.
- Si el niño pierde la conciencia es preferible acostarlo con las piernas elevadas y la cabeza de lado para que respire mejor.
- Cuando el malestar y la sensación de debilidad física hayan desaparecido se puede incorporar despacio. Si está acostado, primero debe sentarse y después de unos minutos levantarse.
- Los niños con tendencia a presentar síncope deben aumentar la ingesta diaria de líquidos, más aún si hacen ejercicio.

¿CUÁNDO DEBE CONSULTAR EN UN SERVICIO DE URGENCIAS?

- Cuando el niño tarda en recuperar el conocimiento más de 5 minutos.
- Cuando el síncope se ha producido con el ejercicio, al hacer un esfuerzo o mientras está sentado.
- Si el episodio se ha acompañado de sacudidas de las extremidades o, al final, se ha orinado.

	Guía Hospitalaria: Síncope	VER: 00 Vigencia: jun 2022 Res: 587
--	-----------------------------------	---

Bibliografía

- 1- CP Cánovas. Protocolos diagnósticos y terapéuticos en urgencias de pediatría. Sociedad Española de Urgencias de Pediatría (SEUP), 3ª Edición, 2019.
- 2- A. Tamariz. Síncopes y mareos. Sección Cardiología Pediátrica, Revista Pediatría integral, Hospital Universitario Infantil Niño Jesús. Madrid. 2016
- 3- A. E. Pace. Síncope en Pediatría. (Parte 1 y Parte 2). Archivos Argentina de Pediatría (SAP), 2004.